사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 세팔로스포린계 항생물질에 과민증의 병력이 있는 환자

2) 조산아 및 신생아

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 임신 3개월 이내의 임부

2) 신 · 간장애 환자

3) 혈우병, 혈소판감소증환자

4) 위장관궤양환자

5) 경구섭취가 불량한 환자 또는 비경구영양 환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K결핍증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰한다.)

3. 이상반응

1) 과민증: 일과성의 경미한 두통, 어지러움, 구역이 나타날 수 있다. 매우 드물게 피부발진, 발열, 아나필락시스 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

2) 간장: 드물게 AL-P, GOT, GPT의 증가가 나타날 수 있다.

3) 혈액: 드물게 일과성백혈구감소가 나타날 수 있다.

4) 소화기: 드물게 위막성대장염 등의 혈변을 수반하는 심한 대장염이 나타날 수 있다. 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 또한 때때로 구역, 구토, 식욕부진 등이 나타날 수 있다.

5) 호흡기: 다른 세펨계 항생물질 투여 시 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 이상, 호산구증가 등을 수반하는 간질성 폐렴, PIE증후군 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 부신피질호르몬제 투여등 적절한 처치를 한다.

6) 균교대증: 드물게 구내염, 칸디다증이 나타날 수 있다.

7) 비타민결핍증: 드물게 비타민 K결핍증상(저프로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비타민 B군 결핍증상(설염, 구내염, 식욕부진, 신경염등)이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소기간만 투여한다.

2) 쇽 등의 반응을 예측하기 위해 충분히 문진하고 사전에 피부반응 시험을 실시하는 것이 바람직하다.

3) 쇽 발생에 대비하여 구급처치 준비를 해두고 투여 후에도 환자를 안정한 상태에서 충분히 관찰한다.

4) 1세대 세팔로스포린계 항생제는 내성이 증가하고 있으므로 감수성 시험결과를 참조한다.

5. 상호작용

1) 아미노글리코사이드계 항생물질과 병용투여 시에는 신장애를 증강시킬 수 있으므로 신중히 투여한다.

2) 폴리믹신B, 콜리스틴, 고용량의 이뇨제와 병용투여 시 신장애를 증가시킬 수 있으므로 신중히 투여한다.

3) 고용량의 경구용 항응혈제(헤파린 등)와 병용투여 시 혈액응고계에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 관찰한다.

6. 수유부에 대한 투여

모유로의 소량 이행이 보고되어 있으므로 신중히 투여한다.

7. 적용상의 주의

아미노글리코사이드계 항생물질과 같은 주사기 내에서 혼합주사하지 않는다.